специалисту, не вместо него[65]. Расписание смен описано в больничных работах, включая целочисленную оптимизацию в онкологии: ограничения, черновик, утверждает человек; это не дома ухода[565766]. Реминисценция и персональная музыка звучат в языке практики и в рамке ухода, где на первом месте то, что важно самому человеку, — но прагматическое испытание персональной музыки в 54 домах ухода значимо не снизило возбуждение; лечебных обещаний нет[58596768]. Пресс PointClickCare (июнь 2026, не рецензия) называет Chart Advisor инструментом «дыры в документации и высокий риск — человеку» и отдельно продаёт направления, счета и американскую оценку MDS/PDPM. Последние три для российских домов не берём[60]. Обзор искусственного интеллекта в клинической документации говорит о качестве и времени черновика, не об автоподписи и не о дописывании карты с датчиков[69].

Семь строк — не новая карта вместо A–E и не приглашение купить американскую платформу для домов сестринского ухода. Это отфильтрованные расширения. Логистика лекарств и график смен ставятся после дисциплины документов. Реминисценция — мягкий слой направления Г, без статуса лечения. Дайджесты — документная задача с фиксированными полями. Подсветка журналов — продолжение А и Е. Питание — кухня и учёт, не «искусственный интеллект-диетолог». Кожа — фото медсестре и пакет поворотов, не автолечение и не робот-сиделка (раздел 23.5). Во всех семи строках человек подтверждает сигнал или черновик; определение этого принципа — в разделе 5.3.

Поэтому отдельную строку про счета, направления и американскую оценку изобретать не надо. Кандидат, не прошедший фильтры раздела 7.3 или этический фильтр раздела 20.4, остаётся в наблюдении — не в закупке.

> **ТЕЗИС.** Кандидаты Ж–Н расширяют карту A–E, а не заменяют её. Ни одна из семи строк не переносит на учреждение клинический автопилот, американские счета или робота-сиделку.

4.3. Кандидат М. Питание и кухня: сначала операция, не клиника

На кухне уже есть замер, который не притворяется клиникой. В доме ухода в Буросе (Швеция, 2025) «умный» контейнер измерял пищевые отходы как хозяйственную задачу: обед в среднем 78 г на порцию (52 % с тарелки, 48 % с раздачи), ужин 58 г (68 % и 31 %). Смешанные блюда и картофель давали наибольший вклад. Это учёт и классификация отходов — фундамент для последующей автоматизации, не клинический диагноз недоедания[61]. Больничный обзор ESPEN (12 работ) показывает, что модели недоедания в стационаре иногда дают точность выше 90 % — но это больница, не дом ухода. Отдельный систематический обзор фиксирует: больше 90 % таких моделей не входят в повседневную практику[6263]. Назначение текстуры при *дисфагии* (нарушении глотания) — задача врача и диетолога (безопасность глотка, питательность), а не решение камеры по фото тарелки[64]. Международная инициатива по стандартизации диет при дисфагии (англ. *International Dysphagia Diet Standardisation Initiative*, IDDSI) описывает для этого восьмиуровневую шкалу, от жидкостей разной густоты до обычной пищи, с простыми тестами, которые выполняет человек на кухне и у постели[296].